

WIREFRAME FUNCIONAL

Perfil Administración

Plataforma asistencial y de comunicación con familias

Versión	v0.1 · Documento consolidado para prototipo
Fecha	29 de agosto de 2026
Base funcional	PRD v0.2 + Wireframes Auxiliar, Enfermería, Medicina y Portal Familiar + AGENTS.md v1.1 + decisiones cerradas durante la revisión de Administración
Ámbito	Residencias geriátricas · prototipo con datos ficticios
Estado	Cerrado funcionalmente para construir el prototipo navegable
Usuario	Administración del centro; Dirección/Coordinación clínica queda como perfil separado pendiente

Principio rector. Administración organiza la estructura, usuarios, ubicaciones, autorizaciones familiares, agendas, turnos, configuración y trazabilidad administrativa. No participa en actos clínicos, no modifica registros asistenciales y no obtiene por defecto acceso al historial clínico ni a la línea temporal interna.

Regla de separación. Administración y Dirección/Coordinación clínica son perfiles distintos. El acceso clínico de supervisión, indicadores y calidad asistencial se definirá en un wireframe posterior de Dirección Clínica.

1. Decisiones funcionales cerradas

Decisión	Definición funcional
Separación de roles	Administración gestiona organización y operación; Dirección/Coordinación clínica se define aparte.
Acceso clínico	Administración no tiene acceso clínico general en v0.1; no consulta valoraciones, constantes, indicaciones, seguimientos ni línea temporal interna.
Alta de residente	Administración crea identidad y ubicación; Enfermería completa el estado basal. Enfermería puede conservar permiso de alta en centros que lo configuren.
Estructura física	Se modelan centro, edificio opcional, planta opcional, unidad/sector, habitación y plaza/cama.
Organigrama	Se separa cargo organizativo de rol del sistema. El organigrama no concede permisos por sí mismo.
Usuarios	Administración crea, activa, suspende y asigna usuarios; los permisos se validan en servidor.
Turnos	Se incorpora planificación básica de personal con fechas múltiples y recurrencias. No incluye nómina, fichaje ni cálculo laboral avanzado.
Autorizaciones familiares	Familiar/contacto y autorización son objetos distintos. Solo una autorización Activa permite acceso al Portal Familiar.
Contacto urgente	Puede designarse un contacto familiar para el circuito de comunicación urgente.
Publicación familiar	Administración configura frecuencia y horario, pero no redacta ni aprueba contenido familiar.
Citas	Módulo configurable por centro. Puede funcionar como Reserva directa o Solicitud previa.
Reserva directa	En centros con agenda estable, el familiar ve huecos disponibles, selecciona uno y confirma sin intervención administrativa.
Modalidad de cita	Presencial, telefónica o videoconferencia, según

Decisión	Definición funcional
	disponibilidad del centro.
Profesional concreto	El familiar solicita Equipo médico o Enfermería; no elige profesional concreto. Internamente el centro puede asignarlo.
Retirada excepcional	Solo por privacidad/seguridad/audiencia o residente incorrectos, con permiso específico, motivo y auditoría.
Auditoría	Las acciones administrativas sensibles conservan usuario, fecha/hora, objeto afectado y motivo cuando proceda.

2. Mapa funcional del perfil

Paso	Bloque	Resultado
1	Inicio	Tareas administrativas pendientes y accesos principales.
2	Residentes y ubicaciones	Identidad administrativa, unidad, habitación y plaza/cama.
3	Organización	Centro, edificios, plantas, unidades y organigrama.
4	Personal	Usuarios, roles, asignaciones y planificación de turnos.
5	Familias	Contactos, cuentas y autorizaciones.
6	Comunicación	Frecuencias y horarios de publicación familiar.
7	Citas	Configuración, agenda, reserva y seguimiento.
8	Publicaciones	Estado administrativo/técnico sin edición clínica.
9	Seguridad	Suspensiones, sesiones, permisos y acciones excepcionales.
10	Auditoría	Trazabilidad administrativa.

3. Navegación principal

ADMINISTRACIÓN

INICIO

RESIDENTES

- Residentes
- Altas
- Ubicaciones

ORGANIZACIÓN

- Estructura del centro
- Unidades
- Habitaciones y camas
- Organigrama

PERSONAL

- Usuarios
- Roles y permisos
- Asignaciones
- Planificación / turnos

FAMILIAS

- Familiares
- Autorizaciones
- Configuración de comunicación

CITAS

- Agenda
- Solicitudes
- Configuración

PUBLICACIONES

- Estado administrativo

CONFIGURACIÓN

AUDITORÍA

MI CUENTA

ADM-01. Inicio de Administración

Objetivo: Mostrar únicamente asuntos administrativos que requieren actuación.

CENTRO RESIDENCIAL X

Administración · Laura Martínez

[Salir]

REQUIERE ATENCIÓN

3 autorizaciones pendientes · 2 incidencias de agenda

1 usuario pendiente de activación · 1 autorización próxima a caducar

[GESTIONAR AUTORIZACIONES] [GESTIONAR CITAS]

ORGANIZACIÓN

124 residentes · 37 profesionales activos · 6 unidades
163 familiares con autorización activa

[RESIDENTES] [PERSONAL] [ESTRUCTURA] [FAMILIAS]
[CITAS] [PUBLICACIONES] [CONFIGURACIÓN] [AUDITORÍA]

- No se muestran eventos clínicos, escalados, constantes, seguimientos ni indicaciones.
- Los contadores son administrativos y respetan el centro autorizado.

ADM-02. Lista de residentes

Objetivo: Administrar identidad y ubicación sin convertir la pantalla en una ficha clínica.

RESIDENTES

Buscar []

Filtros: Unidad · Ubicación · Activo/inactivo · Autorización familiar

MARÍA GARCÍA · 86 años

Unidad 2 · Planta 1 · Habitación 101 · Cama A

Estado: ACTIVA · Familiares autorizados: 2 · Frecuencia: diaria

[ABRIR FICHA ADMINISTRATIVA]

- Datos clínicos como Barthel, CFS, diagnósticos, eventos o constantes no aparecen en esta vista.

ADM-03. Ficha administrativa del residente

Objetivo: Centralizar información administrativa, ubicación y configuración familiar.

MARÍA GARCÍA

DATOS ADMINISTRATIVOS

Nombre · fecha de nacimiento · sexo · identificador interno

Centro · edificio · planta · unidad · habitación · plaza/cama

[EDITAR DATOS ADMINISTRATIVOS]

ACCESO FAMILIAR

Ana García · Hija · Autorización ACTIVA

Carlos García · Hijo · Autorización ACTIVA

[GESTIONAR FAMILIARES]

COMUNICACIÓN

Frecuencia: DIARIA

Contacto urgente: Ana García

[CONFIGURAR COMUNICACIÓN]

- Aviso visible: esta pantalla contiene información administrativa; la información asistencial se gestiona desde perfiles profesionales.

ADM-04. Alta administrativa de residente

Objetivo: Crear la identidad organizativa y dejar el basal a Enfermería.

NUEVO RESIDENTE

Nombre *

Fecha de nacimiento *
 Sexo *
 Identificador interno

UBICACIÓN
 Centro * · edificio · planta · unidad * · habitación · plaza/cama

[GUARDAR Y CREAR RESIDENTE]

RESULTADO
 Residente creado
 Estado basal: PENDIENTE DE COMPLETAR POR ENFERMERÍA

- Antes de guardar se confirma identidad y ubicación.
- El sistema advierte posibles duplicados.
- El centro puede otorgar a Enfermería permiso adicional de alta si su organización lo requiere.

ADM-05. Estructura física del centro

Objetivo: Modelar la organización real del centro para facilitar asignaciones y localización.

ESTRUCTURA DEL CENTRO

CENTRO RESIDENCIAL X

▼ Edificio principal
 ▼ Planta baja
 ▼ Unidad 1
 Habitación 001
 Cama A · María García
 Cama B · Libre
 Habitación 002
 Cama A · José Martínez
 ▼ Primera planta
 ▼ Unidad 2
 Habitación 101
 Habitación 102

[+ EDIFICIO] [+ PLANTA] [+ UNIDAD]
 [+ HABITACIÓN] [+ PLAZA / CAMA]

- Edificio y planta son niveles opcionales para adaptarse a centros con estructuras diferentes.
- La estructura física no concede permisos por sí sola.

ADM-06. Gestión de habitación y plaza/cama

Objetivo: Gestionar capacidad y ocupación administrativa.

HABITACIÓN 101
 Planta: Primera · Unidad: Unidad 2
 Tipo: [Doble ▼]

PLAZAS
 Cama A · Ocupada · María García
 Cama B · Libre

[GESTIONAR UBICACIÓN]

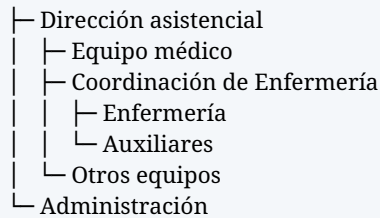
- Los cambios de ubicación quedan auditados.
- No se incorporan en v0.1 funciones hoteleras, facturación o mantenimiento de habitaciones.

ADM-07. Organigrama del centro

Objetivo: Representar la estructura organizativa sin confundir cargo con permisos.

ORGANIGRAMA DEL CENTRO

Dirección



[EDITAR ORGANIGRAMA]

- Rol del sistema y cargo organizativo son conceptos distintos.
- El organigrama no modifica autorizaciones automáticamente.

ADM-08. Familiares vinculados

Objetivo: Gestionar contactos sin confundir vínculo con autorización de acceso.

FAMILIARES DE MARÍA GARCÍA

Ana García · Hija

Cuenta: ACTIVA · Autorización: ACTIVA · Contacto urgente: SÍ

[VER / GESTIONAR]

Carlos García · Hijo

Cuenta: ACTIVA · Autorización: ACTIVA

[VER / GESTIONAR]

[+ AÑADIR FAMILIAR]

- Vincular un familiar no concede acceso al portal.
- La autorización se gestiona como objeto independiente.

ADM-09. Crear familiar

Objetivo: Registrar un contacto y continuar, si procede, a la autorización.

NUEVO FAMILIAR

Nombre *

Apellidos *

Relación con residente *

Correo electrónico *

Teléfono

[GUARDAR Y CONTINUAR]

FAMILIAR REGISTRADO

Este registro todavía NO concede acceso al residente.

[CREAR AUTORIZACIÓN] [FINALIZAR]

ADM-10. Autorización familiar

Objetivo: Gestionar el acceso al Portal Familiar con estados trazables.

AUTORIZACIÓN FAMILIAR

Residente: María García

Familiar: Ana García

Estado: ACTIVA

Fecha de inicio *

Fecha de finalización [opcional]

Acceso al Portal Familiar ☒ AutorizadoContacto designado para situaciones urgentes ☒ Sí

[GUARDAR]

Acciones: [SUSPENDER] [REVOCAR]

- Estados: Pendiente · Activa · Suspendida · Revocada · Caducada.
- Solo Activa concede acceso.
- Una revocación debe impedir nuevas consultas incluso si existía una sesión abierta.

ADM-11. Revocar o suspender autorización

Objetivo: Bloquear acceso sin eliminar la trazabilidad histórica.

REVOCAR AUTORIZACIÓN

Motivo *

[.....]

La revocación impedirá inmediatamente nuevas consultas.

[CANCELAR] [CONFIRMAR REVOCACIÓN]

- No se elimina al familiar ni las publicaciones históricas internas.
- Usuario, fecha/hora y motivo quedan auditados.

ADM-12. Usuarios profesionales

Objetivo: Gestionar cuentas profesionales del centro.

USUARIOS

Buscar [_____]

Filtros: Rol · Unidad · Estado

Marta Pérez · Enfermería · Unidad 2 · ACTIVA
[GESTIONAR]

Juan Pérez · Medicina · Unidades 1-2-3 · ACTIVO
[GESTIONAR]

[+ NUEVO USUARIO]

ADM-13. Alta y gestión de usuario profesional

Objetivo: Crear cuenta, rol, asignaciones y controles de seguridad.

NUEVO USUARIO

Nombre * · Apellidos * · Correo/identificador *

Rol *: Auxiliar / Enfermería / Medicina / Administración

ASIGNACIONES

Centro: Centro Residencial X

Unidades autorizadas: ☒ Unidad 1 ☒ Unidad 2 ☐ Unidad 3

[CREAR USUARIO]

GESTIÓN POSTERIOR

[MODIFICAR ASIGNACIONES] [SUSPENDER USUARIO]

[CERRAR TODAS LAS SESIONES] [RECUPERACIÓN DE ACCESO]

- No existe acción ordinaria “Entrar como este usuario”.
- Los permisos se aplican en servidor; ocultar un botón no es control de acceso.

ADM-14. Planificación semanal de personal

Objetivo: Visualizar cobertura básica por día, turno, unidad y categoría.

PLANIFICACIÓN DE PERSONAL

Semana 31 agosto - 6 septiembre

	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE
MAÑANA					
Auxiliares	4	4	4	4	4
Enfermería	2	2	2	2	2
Medicina	Dr A	Dr A	Dr B	Dr A	Dr B

TARDE					
Auxiliares	4	4	4	4	4
Enfermería	2	2	2	2	2

NOCHE					
Auxiliares	2	2	2	2	2
Enfermería	1	1	1	1	1

[EDITAR PLANIFICACIÓN]

- La planificación no sustituye permisos de seguridad.
- No incluye nóminas, fichajes, convenio, vacaciones avanzadas ni cálculo de jornada anual.

ADM-15. Asignación de turnos en varias fechas

Objetivo: Permitir asignar el mismo turno a varias fechas concretas.

ASIGNAR TURNO

Profesional: Marta Pérez

Unidad: Unidad 2

Turno: Mañana · 07:00-15:00

FECHAS

☒ 01/09 ☒ 02/09 ☒ 03/09 ☒ 04/09 ☐ 05/09

☒ 08/09 ☒ 09/09 ☐ 10/09

[ASIGNAR A LAS FECHAS SELECCIONADAS]

- Se admite selección múltiple de fechas para evitar introducir turno por turno.

ADM-16. Turno recurrente y excepciones

Objetivo: Crear patrones de trabajo repetidos y modificar días aislados.

ASIGNAR TURNO RECURRENTE

Profesional: Marta Pérez

Unidad: Unidad 2

Turno: Mañana · 07:00-15:00

Periodo: Desde [01/09/2026] Hasta [30/09/2026]

Días: ☒ Lunes ☒ Martes ☒ Miércoles ☒ Jueves ☒ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo

[CREAR PLANIFICACIÓN]

AL EDITAR UNA FECHA

[MODIFICAR ESTE DÍA] [MODIFICAR TODA LA SERIE]

- Una excepción no destruye la serie completa.
- La plataforma detecta solapamientos y los muestra; no decide automáticamente cómo resolverlos.

ADM-17. Detección de conflictos de planificación

Objetivo: Evitar dobles asignaciones evidentes.

⚠ CONFLICTO DE PLANIFICACIÓN

Marta Pérez ya tiene asignado:

Unidad 1 · 07:00-15:00

para 4 de las fechas seleccionadas.

[VER CONFLICTOS] [CANCELAR]

- El administrador decide la corrección.
- No se implementa optimización automática de cuadrantes en v0.1.

ADM-18. Configuración de comunicación familiar

Objetivo: Configurar frecuencia ordinaria por residente.

COMUNICACIÓN FAMILIAR María García MODALIDAD ORDINARIA ☐ Diaria ☐ Semanal ☐ Solo actualizaciones relevantes [GUARDAR]
--

- Administración configura cuándo; Enfermería/Medicina deciden y aprueban qué se publica.

ADM-19. Horarios de publicación

Objetivo: Definir cuándo se hacen visibles las publicaciones ordinarias aprobadas.

PROGRAMACIÓN DE PUBLICACIONES RESÚMENES DIARIOS Hora: [19:00] RESÚMENES SEMANALES Día: [Domingo ▼] Hora: [19:00] [GUARDAR CONFIGURACIÓN]
--

- Las actualizaciones relevantes no dependen de este horario cuando han sido aprobadas.
- El sistema no genera contenido si no existe una publicación aprobada.

ADM-20. Estado administrativo de publicaciones

Objetivo: Supervisar funcionamiento sin otorgar acceso clínico innecesario.

PUBLICACIONES Hoy 32 programadas · 30 publicadas · 2 pendientes · 0 errores técnicos María García Resumen diario · PROGRAMADA · prevista 19:00 [VER ESTADO]

- Por defecto no se muestra el texto clínico/familiar completo.
- Administración no redacta, aprueba ni edita publicaciones.

ADM-21. Configuración del servicio de citas

Objetivo: Permitir que cada centro decida si ofrece citas y cómo se gestionan.

GESTIÓN DE CITAS FAMILIARES

Servicio: ☒ Activado ☐ Desactivado

Sistema de reserva:

- ☒ Reserva directa en horarios disponibles
☐ Solicitud previa y propuesta del centro

Equipos disponibles: ☒ Enfermería ☒ Equipo médicoModalidades: ☒ Presencial ☒ Telefónica ☐ Videoconferencia

[CONFIGURAR AGENDA]

- Reserva directa es la opción recomendada cuando existen franjas estables.
- La videoconferencia solo aparece si el centro dispone de ella; v0.1 no crea una plataforma propia de videollamada.

ADM-22. Configuración de disponibilidad para citas**Objetivo:** Crear franjas recurrentes por equipo, duración y modalidad.

DISPONIBILIDAD PARA CITAS

ENFERMERÍA

Lunes 10:00-11:00 · Duración 15 min

Miércoles 10:00-11:00 · Duración 15 min

Viernes 10:00-11:00 · Duración 15 min

[+ AÑADIR FRANJA]

EQUIPO MÉDICO

Jueves 16:00-17:00 · Duración 20 min

[+ AÑADIR FRANJA]

Reglas opcionales:

Antelación mínima · horizonte máximo · periodos bloqueados

[GUARDAR]

- Días, horas y duración son configurables por centro.
- Agenda y planificación de turnos quedan diseñadas para poder relacionarse progresivamente.

ADM-23. Agenda semanal de citas**Objetivo:** Visualizar huecos, reservas y disponibilidad operativa.

AGENDA DE CITAS

Semana 31 agosto - 6 septiembre

Filtro: [Enfermería ▼] [Todas las modalidades ▼]

	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE
10:00	Libre		Libre		Libre
10:15	Ana G.		Libre		Libre
10:30	Libre		Libre		Libre
16:00			Carlos M.		
16:20			Libre		

16:40

Libre

[< SEMANA ANTERIOR] [SIGUIENTE SEMANA >]

ADM-24. Reserva directa desde Portal Familiar

Objetivo: Reducir carga administrativa permitiendo reservar huecos reales.

FLUJO FAMILIAR
 Seleccionar equipo
 ↓
 Elegir modalidad disponible
 ↓
 Ver huecos libres
 ↓
 Seleccionar fecha/hora
 ↓
 Confirmar
 ↓
 CITA CONFIRMADA

- El familiar selecciona Equipo médico o Enfermería, no un profesional concreto.
- Dos usuarios no pueden confirmar el mismo hueco: la reserva debe ser transaccional e idempotente.
- Si el hueco acaba de ocuparse, se informa y se ofrecen otros disponibles.

ADM-25. Gestión administrativa de cita

Objetivo: Permitir intervención manual cuando el centro use solicitud previa o necesite ajustar una cita.

SOLICITUD / CITA
 Residente: María García
 Solicitante: Ana García
 Equipo: EQUIPO MÉDICO

Fecha * [03/09/2026]
 Hora * [16:20]
 Modalidad * [Presencial ▼]
 Profesional asignado [Dr. Juan Pérez ▼]
 Nota administrativa opcional [.....]

[GUARDAR / ENVIAR PROPUESTA]

- Modalidades: presencial, telefónica o videoconferencia según configuración del centro.
- El profesional concreto puede asignarse internamente sin exponer la elección al familiar.

ADM-26. Estados y cambios de cita

Objetivo: Mantener un flujo simple en reserva directa y compatible con solicitud previa.

RESERVA DIRECTA

Disponible → Confirmada → Finalizada
 └─ Reprogramada → Confirmada
 └─ Cancelada

SOLICITUD PREVIA

Pendiente de gestión → Propuesta por el centro → Confirmada
 └─ Solicitud de cambio
 └─ Cancelada

- En reserva directa, Cambiar cita vuelve a mostrar huecos disponibles.
- Las modificaciones quedan trazadas.

ADM-27. Retirada excepcional de publicación

Objetivo: Retirar contenido por privacidad/seguridad sin usar esta acción como corrección ordinaria.

RETIRADA EXCEPCIONAL

Publicación: Actualización 24/08/2026

Residente: María García

Motivo *

- ☐ Residente incorrecto
- ☐ Audiencia incorrecta
- ☐ Confidencialidad / privacidad
- ☐ Incidente de seguridad
- ☐ Otro

Explicación * [.....]

[CANCELAR] [CONFIRMAR RETIRADA]

- Requiere permiso específico.
- El original permanece íntegro en auditoría y no puede usarse esta función para corregir redacción ordinaria.

ADM-28. Auditoría administrativa

Objetivo: Consultar la trazabilidad de acciones sensibles.

AUDITORÍA

Filtros: Fecha · Usuario · Acción · Residente · Familiar

28/08/2026 10:14 · Laura Martínez

Activó autorización familiar · María García

28/08/2026 10:20 · Laura Martínez

Cambió frecuencia: Semanal → Diaria

28/08/2026 11:03 · Laura Martínez

Suspendió usuario

- Incluye usuarios, roles, asignaciones, autorizaciones, frecuencia, contacto urgente, horarios, citas, retirada excepcional y acciones de seguridad.

- No se utiliza la auditoría administrativa para mostrar texto clínico completo.

ADM-29. Configuración del centro

Objetivo: Gestionar parámetros previamente definidos por producto sin introducir reglas clínicas nuevas.

CONFIGURACIÓN CENTRO Nombre · datos identificativos · contacto ORGANIZACIÓN [ESTRUCTURA] [UNIDADES] COMUNICACIÓN FAMILIAR [HORARIOS] CITAS [REGLAS DE RESERVA] SEGURIDAD Política de sesión · segundo factor CORRECCIONES Ventana ordinaria configurada: 6 horas [GUARDAR]
--

- La configuración administrativa no puede alterar categorías clínicas ni crear umbrales diagnósticos o urgentes.
- Parámetros sensibles deben provenir de reglas ya aprobadas por producto/centro.

ADM-30. Mi cuenta y seguridad

Objetivo: Permitir al administrador gestionar su propia seguridad.

MI CUENTA Laura Martínez · Administración [CAMBIAR CONTRASEÑA] [GESTIONAR SEGUNDO FACTOR] [CERRAR OTRAS SESIONES] [CERRAR SESIÓN]

4. Flujos funcionales consolidados

4.1 Organización y alta

ADMINISTRACIÓN



Crear residente

↓
Asignar ubicación física
↓
Residente activo
↓
Estado basal pendiente
↓
ENFERMERÍA completa basal

4.2 Familia y acceso

Crear/vincular familiar
↓
Crear autorización
↓
Pendiente / Activa / Suspendida / Revocada / Caducada
↓
Solo ACTIVA permite Portal Familiar

4.3 Citas - reserva directa

Centro configura franjas
↓
Familiar selecciona equipo/modalidad
↓
Ve solo huecos disponibles
↓
Selecciona y confirma
↓
Cita confirmada
↓
Puede reprogramar o cancelar

4.4 Turnos

Profesional + unidad + turno
↓
Fechas múltiples O recurrencia
↓
Detección de conflictos
↓
Guardar planificación
↓
Excepciones por día sin destruir la serie

5. Límites del perfil Administración

Administración puede

- Gestionar centro, estructura física, unidades, habitaciones y plazas/camas.
- Crear y gestionar usuarios, roles ya definidos y asignaciones.
- Planificar turnos básicos mediante fechas múltiples y recurrencias.
- Gestionar identidad administrativa de residentes y su ubicación.
- Gestionar familiares y autorizaciones.
- Designar contacto familiar urgente.
- Configurar frecuencia y horarios de publicación.
- Configurar y gestionar la agenda de citas.
- Consultar estado administrativo/técnico de publicaciones.
- Realizar retirada excepcional si dispone del permiso específico.
- Consultar auditoría administrativa según permisos.

Administración no puede

- Registrar observaciones o valoraciones clínicas.
- Modificar estado basal, Barthel, CFS, cognición o diagnósticos.
- Registrar constantes, escalados, seguimientos o indicaciones.
- Cerrar eventos asistenciales.
- Redactar o aprobar publicaciones familiares.
- Editar retrospectivamente publicaciones ya publicadas.
- Acceder por defecto al historial clínico o a la línea temporal interna.
- Modificar registros firmados por profesionales.
- Cambiar reglas clínicas o introducir automatizaciones diagnósticas.
- Usar cuadrantes u organigrama como sustituto del sistema de autorización de seguridad.

6. Criterios de aceptación del prototipo

- ☐ Administración solo accede a su centro autorizado.
- ☐ Cambiar URL o identificadores no concede acceso a otro centro/residente.
- ☐ Administración no visualiza información clínica por defecto.
- ☐ Alta administrativa y basal profesional quedan separados.
- ☐ La estructura admite edificio/planta opcionales, unidad, habitación y plaza/cama.
- ☐ Cargo organizativo y rol del sistema permanecen separados.
- ☐ Familiar y autorización son objetos distintos.
- ☐ Solo autorización Activa concede acceso al Portal Familiar.
- ☐ Revocar autorización bloquea nuevas consultas.

- ☐ Se puede designar un contacto familiar urgente.
- ☐ Usuarios profesionales disponen de cuentas individuales y permisos en servidor.
- ☐ Los turnos permiten seleccionar múltiples fechas.
- ☐ Los turnos permiten recurrencias por días de la semana y periodo.
- ☐ Una excepción de un día no destruye la serie recurrente.
- ☐ Los solapamientos se detectan y se muestran sin resolverlos automáticamente.
- ☐ Cuadrante y autorización de seguridad son conceptos distintos.
- ☐ Frecuencia diaria/semanal/solo relevantes se configura por residente.
- ☐ Día/hora de publicaciones ordinarias se configura por centro.
- ☐ Administración no redacta ni aprueba publicaciones.
- ☐ Citas puede activarse/desactivarse por centro.
- ☐ Citas permite Reserva directa o Solicitud previa.
- ☐ En Reserva directa el familiar ve únicamente huecos disponibles.
- ☐ El familiar selecciona equipo y modalidad, no profesional concreto.
- ☐ El familiar puede confirmar, reprogramar o cancelar.
- ☐ No pueden confirmarse dos reservas para el mismo hueco.
- ☐ Retirada excepcional exige motivo, permiso y auditoría.
- ☐ Las acciones administrativas sensibles conservan trazabilidad.

7. Pendientes trasladados fuera de este wireframe

- Crear el wireframe de Dirección/Coordinación clínica con alcance limitado de supervisión, calidad e indicadores.
- Actualizar el Portal Familiar para reflejar reserva directa, reprogramación/cancelación y modalidades de cita.
- Actualizar el PRD en una siguiente versión consolidada con Administración y Portal Familiar cerrados.
- Actualizar AGENTS.md con los límites definitivos entre Administración y Dirección, agenda, estructura y turnos.

- Validar con centros piloto si activan el servicio de citas, tiempo destinado, días, modalidades y equipos responsables.
- Validar con centros piloto el alcance de la planificación de personal antes de ampliar a vacaciones, ausencias o reglas laborales.
- Definir política jurídica definitiva de conservación/retención y permisos productivos con DPO/asesoría.
- Definir implementación productiva de autenticación/segundo factor y soporte excepcional.

8. Resultado funcional esperado

El perfil Administración actúa como núcleo organizativo y operativo del centro: estructura física, usuarios, turnos, residentes, familias, autorizaciones, comunicación, citas y configuración. Mantiene una frontera clara frente al trabajo asistencial y deja la supervisión clínica para un perfil separado de Dirección/Coordinación. La agenda de citas puede automatizar la reserva cuando el centro disponga de franjas estables, y la planificación de personal aporta contexto operativo sin convertirse todavía en un sistema completo de recursos humanos.

Advertencia de uso. Este wireframe define el comportamiento funcional del prototipo. No constituye una historia clínica homologada, una EIPD, una validación jurídica, una política laboral, una certificación de seguridad ni autorización para utilizar datos sanitarios reales.